HELP_Organi_P04 — Critique — 15 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 4 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

E-056 — Critique — LOT 244 · SSP O7.22

Emplacement : LOT_244_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.5 › syndrome sérotoninergique (tableau d'interprétation, benzodiazépines, antagonistes 5-HT2A, surveillance)

Contexte : Le cours cite le midazolam (Dormicum®, Midazolam Accord®, Sintetica) sans posologie, chlorpromazine 12,5–100 mg et olanzapine 5–10 mg « cas rapportés » ; cyproheptadine sans statut suisse ; CK et bilan hépatique sans seuil.

Question : Quel traitement du syndrome sérotoninergique recommandent Tox Info Suisse ou la recommandation européenne la plus récente : benzodiazépine (molécule, dose, voie), cyproheptadine (dose de charge et d'entretien, disponibilité en Suisse ou importation), chlorpromazine et olanzapine (place, dose), refroidissement et curarisation au-delà de 40 °C ; seuils de CK et calendrier de surveillance ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :

6. Certitude et réserves :

E-058 — Critique — LOT 244 · SSP O7.22

Emplacement : LOT_244_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.7 › tableau thérapeutique des torsades de pointes (magnésium, isoprénaline, citalopram, dompéridone, méthadone) et surveillance ECG

Contexte : Le cours cite sulfate de magnésium « Bichsel » (8 mmol i.v. lent, liste suisse des antidotes), Isuprel® hors indication 0,5–10 µg/min, Seropram® max 40 mg (20 mg > 65 ans), Motilium® ; posologie de la méthadone et intervalle des ECG absents.

Question : Quelle conduite face aux torsades de pointes recommandent l'ESC 2022 (arythmies ventriculaires) et la liste suisse des antidotes : magnésium (dose, répétition), isoprénaline ou stimulation, correction du potassium (cible) ? Selon les FI suisses de Méthadone Streuli®, Seropram® et Motilium®, quelles posologies, quelles limites de QTc et quel calendrier d'ECG s'appliquent ? Préciser les recommandations suisses sur l'ECG sous méthadone (SSAM). Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-059 — Critique — LOT 244 · SSP O7.22

Emplacement : LOT_244_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.8 › angio-œdème bradykinique aux IEC (lieu de surveillance, forme intestinale, adrénaline, surveillance)

Contexte : Le cours écrit que la dose d'adrénaline dans l'angio-œdème bradykinique sans anaphylaxie n'est pas fixée, que le lieu et le calendrier de surveillance sont absents ; Firazyr® et Berinert® cités pour l'AOH.

Question : Quelle prise en charge de l'angio-œdème bradykinique aux IEC recommandent une source suisse (SSAI, guidelines.ch, Tox Info Suisse) ou européenne la plus récente (EAACI, WAO/EAACI 2021 sur l'AOH en comparaison) : arrêt de l'IEC, sécurisation des voies aériennes, place de l'icatibant et du C1-INH (hors indication en Suisse ?, dose), place de l'adrénaline, lieu et durée de surveillance, relais par un sartan ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-072 — Critique — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_245_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 2 › tableau

thérapeutique DX.4 (hydroxycarbamide, pénicilline) ; Partie 2 › DX.4 › prévention (pénicilline, vaccins, acide folique), Litalir®

Contexte : Le cours cite l'hydroxycarbamide hors indication (Litalir®, SwissPedDose 15–20 puis 20–30 mg/kg/j, max 35 mg/kg/j) ; posologie adulte, posologie et durée de la pénicilline, rationnel de l'acide folique et forme pédiatrique adaptée absents.

Question : Quelle prophylaxie de la drépanocytose recommandent SwissPedDose, la Société suisse d'hématologie ou la recommandation européenne la plus récente (EHA 2024, HAS 2024 en comparaison) : pénicilline V (dose selon l'âge, durée, adulte), vaccins (pneumocoque, méningocoque), acide folique ; hydroxycarbamide chez l'adulte (dose de départ, titration, surveillance de l'hémogramme) ; existe-t-il en Suisse une forme pédiatrique (Siklos®) autorisée ou importable ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-073 — Critique — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.4 › fenêtres « fièvre supérieure à 38,5 °C », « pâleur brutale avec asthénie » (séquestration) et « syndrome thoracique aigu »

Contexte : Le cours dit « consultation urgente » sans antibiothérapie, sans seuils d'hémoglobine pour la séquestration et sans définition du syndrome thoracique aigu (texte HAS non lu).

Question : Quelle conduite face à la fièvre (antibiothérapie empirique : molécule, dose), à la séquestration splénique aiguë (seuil de baisse de l'hémoglobine, transfusion) et au syndrome thoracique aigu (définition, antibiotiques, transfusion ou échange) recommandent une source suisse (centres de référence, SwissPedNet) ou européenne la plus récente (EHA, BSH 2024, HAS 2024) ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-076 — Critique — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_245_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 2 › tableau thérapeutique DX.5 (D-pénicillamine, acétate de zinc) ; Partie 2 › DX.5 › chélateurs (D-pénicillamine, trientine) et zinc

Contexte : Le cours dit que les FI suisses de la D-pénicillamine et de l'acétate de zinc ne figurent pas dans AIPS ; importation par OAMal art. 71c ; posologies absentes.

Question : Quels traitements de la maladie de Wilson sont disponibles en Suisse (D-pénicillamine Metalcaptase®, trientine Cufence® ou Cuprior®, acétate de zinc Wilzin®) : statut Swissmedic ou voie d'importation, posologies d'attaque et d'entretien chez l'adulte et l'enfant, surveillance (cuivre urinaire cible), conduite en grossesse, selon les recommandations EASL-ERN 2025 ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-084 — Critique — LOT 246 · SSP O7.24

Emplacement : LOT_246_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc 1 › V. diagnostics différentiels (delirium : halopéridol) et tableau des moyens pharmacologiques ; Partie 1 › DX.2 › surveillance et pronostic

Contexte : Le cours cite halopéridol max 10 mg/j avec ECG, 0,5 mg/j chez l'âgé dans l'agitation de la démence ; adaptations rénale et hépatique de toutes les spécialités, calendrier biologique et pronostic absents.

Question : Quel traitement pharmacologique du delirium et des SCPD chez la personne âgée recommandent les recommandations suisses (SSGG/SPSG, guidelines Felix Platter ou HUG, SGAP) ou européennes récentes (EuGMS, NICE en comparaison) : halopéridol, rispéridone, quétiapine, lorazépam (doses, durée, QTc), adaptations rénale et hépatique selon les FI suisses, calendrier de surveillance ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-088 — Critique — LOT 246 · SSP O7.24

Emplacement : LOT_246_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc 1 › mises en garde (PEP) ; Partie 2 › DX.4 › prophylaxie post-exposition du VIH ; Partie 3 › DX.6 › conditions et exceptions (posologies CFIST chez l'adolescente)

Contexte : Le cours cite une PEP débutée dans les 48 h pendant 28 jours et le dolutégravir (effets neuropsychiatriques) ; schéma antirétroviral en vigueur, calendrier des contrôles et adaptation chez l'adolescente de petit poids absents.

Question : Quel schéma de PEP VIH recommandent l'OFSP et la CFIST/CFSS en vigueur (molécules, doses, durée, délai maximal de 72 h, adaptation au poids et à l'âge chez l'adolescent, grossesse) et quel calendrier de contrôles sérologiques (VIH, VHB, VHC, syphilis) ? Comparer avec EACS 2024. Inclure la prophylaxie des IST et la contraception d'urgence après viol. Pour chaque médicament,

donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-090 — Critique — LOT 246 · SSP O7.24

Emplacement : LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.6 › contraception d'urgence (inducteurs enzymatiques) chez l'adolescente

Contexte : Le cours dit que les inducteurs enzymatiques pris dans les quatre dernières semaines réduisent l'efficacité de la contraception d'urgence ; conduite précise non tranchée.

Question : Quelle conduite recommandent la FI suisse de NorLevo®/levonorgestrel et d'ellaOne® (ulipristal) et les recommandations suisses (SSGO, Santé sexuelle Suisse, IENT) chez une adolescente sous inducteur enzymatique : double dose de lévonorgestrel, DIU au cuivre, délai maximal, contrôle de grossesse, capacité de discernement et remise sans les parents ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-047 — Critique — LOT 218 · SSP O6.5

Emplacement : LOT_218_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Bloc 2 › lacunes (218.15) et point 11.B (antiandrogènes) ; evidence not_found n° 4 et uncertainties n° 4

Contexte : Le cours cite la SSED (dose cumulée de cyprotérone > 10 g) et l'EMA (risque de méningiome surtout ≥ 25 mg/j, lié à la dose cumulée, sans seuil chiffré) ; l'IP d'Androcur®-10 n'a pas été obtenue.

Question : Quelles indications, posologies et mises en garde (méningiome : dose seuil, IRM, contre-indication) prévoient les IP suisses d'Androcur®-10 et d'Androcur®-50 et la communication DHPC de Swissmedic consécutive à l'évaluation EMA 2020, et quelle dose maximale recommande la SSED 2026 en hormonothérapie d'affirmation ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :

4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-055 — Critique — LOT 218 · SSP O6.5

Emplacement : LOT_218_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Bloc 2 › fenêtre « réponse à la naloxone » (DX chemsex / intoxication)

Contexte : Le cours écrit : « Posologie et spécialité suisse ®. Donnée non trouvée dans les sources consultées. » La réponse Gemini (HELP LOT_248 V1, réserve 4) a cité Naloxon OrPha®, Naloxon Labatec® et Nyxoid® d'après la liste des antidotes 2022-23, sans entrée AIPS.

Question : Quelles spécialités de naloxone sont autorisées en Suisse (entrées AIPS : Naloxon OrPha®, Naloxon Labatec®, Nyxoid®) et quelles posologies IV, IM et intranasales (dose initiale, répétition, enfant) prévoient leurs IP et la liste des antidotes Tox Info Suisse la plus récente ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-091 — Critique — LOT 223 · SSP O7.1

Emplacement : LOT_223_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Points 11.B (paludisme grave) et lacunes connues (223.21, 223.25) ; evidence not_found n° 4 et 9

Contexte : Le cours suit l'ESCMID 2012 pour le paludisme grave ; modalités d'obtention de l'artésunate IV en pharmacie hospitalière et base légale de l'importation de médicaments non autorisés (artésunate, primaquine, praziquantel) : « donnée non trouvée ».

Question : Quelle recommandation suisse (OFSP, Swiss TPH, SSI) fixe le traitement du paludisme grave (artésunate IV : dose, schéma, relais oral, surveillance de l'hémolyse retardée), comment l'artésunate est-il obtenu en Suisse (dépôt, importation selon LPTh art. 9 al. 2 ou OAMéd art. 49), et quel est le statut de la primaquine et du praziquantel ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-096 — Critique — LOT 223 · SSP O7.1

Emplacement : LOT_223_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtre bio-mathématique 7.1 (dose d'immunoglobulines antirabiques) ; lacunes (223.27) ; evidence not_found n° 11 et uncertainties n° 2, 3, 12

Contexte : Le cours retient l'OFSP 2026 (PrEP 2 doses J0/J28 ; PEP 4 doses J0/3/7/14) contre l'IP Rabipur® (PrEP 3 doses, PEP 5 doses) ; Berirab® 20 UI/kg (OFSP : une ampoule de 300 UI suffit en règle générale) ; exceptions de PEP pour chiens, chats et furets domestiques non lues.

Question : Que prévoient les directives OFSP/CFV les plus récentes sur la prophylaxie de la rage (schémas PrEP et PEP, immunodéprimé, dose et infiltration des immunoglobulines, exceptions pour animaux domestiques observables en Suisse et à l'étranger), et comment l'IP suisse de Rabipur® et de Berirab® diffère-t-elle ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-118 — Critique — LOT 225 · SSP O7.3

Emplacement : LOT_225_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point V.C › tableau de surveillance (risque de renutrition) ; evidence not_found n° 7

Contexte : Le cours cite Friedli 2018 (algorithme chiffré non lu, résumé seulement) ; calendrier chiffré de la surveillance « donnée non trouvée ».

Question : Quel algorithme de prévention et de traitement du syndrome de renutrition (critères de risque, apport calorique initial par kg, thiamine, phosphate, potassium, magnésium, calendrier de surveillance) fixent Friedli et al. 2018 (consensus suisse) et la ligne directrice ESPEN la plus récente ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL) qui fixe cette conduite. Comparez sa version la plus récente avec celle du cours et listez les différences. À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-033 — Critique — LOT 248 · SSP O7.26

Emplacement : LOT_248_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › tableau différentiel › ligne « Sevrage alcoolique ou aux BZD » ; aussi LOT_221 evidence not_found n° 10 et LOT_222 evidence uncertainties n° 8

Contexte : LOT_248 : « aucune source européenne discriminante », colonne conduite « donnée non trouvée ». LOT_221 : aucune ligne directrice suisse du sevrage d'alcool (CIWA-Ar, ordre thiamine–glucose) ; seules les IP Seresta® et Benerva® lues. LOT_222 : conflit HUG 2017 (oxazépam 60–200 mg/j, CIWA) / IP Seresta® 2026 (15–30 mg 3–4×/j) arbitré en faveur de l'IP.

Question : Quelle recommandation suisse (SSAM, Infodrog, protocole hospitalier publié) ou européenne (EFNS 2010, ou plus récente) fixe la conduite du sevrage alcoolique : score CIWA-Ar et seuils, choix et dose de la benzodiazépine (oxazépam, lorazépam, diazépam), dose et voie de la thiamine (Benerva®) et ordre thiamine–glucose, et critères d'hospitalisation ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL) qui fixe cette conduite. Comparez sa version la plus récente avec celle du cours et listez les différences. À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P04 — 15 questions : E-056, E-058, E-059, E-072, E-073, E-076, E-084, E-088, E-090, F-047, F-055, F-091, F-096, F-118, F-033